

Rezyliencja w chorobie przewlekłej

Choroba zabiera część życia. Rezyliencja to odkrycie, że reszta nadal jest Twoja. Akceptacja nie znaczy rezygnacja — to „nie walczę z faktem, walczę o wartości mimo faktu”.

CZAS: 15 min · poziom średni Choroba przewlekła; ból przewlekły; po diagnozie

ŹRÓDŁO: Stewart & Yuen (2011); Bonanno (2004)

JAK UŻYWAĆ

Ten arkusz dotyczy rezyliencji w chorobie przewlekłej — adaptacji do **trwałej zmiany**, nie jednorazowego kryzysu. Obejmuje cztery obszary: **żałobę po zdrowiu** (prawo do opłakania utraconej sprawności i planów), **akceptację** (uznanie nowej rzeczywistości), **przystosowanie** (skupienie na tym, na co mam wpływ) oraz **tożsamość** (kim jestem poza chorobą). Arkusz pomaga rozdzielić to, na co masz wpływ (leki, dieta, ruch, sen, relacje), od tego, na co nie (przebieg, rokowanie), oraz zauważyć, że choroba jest częścią Ciebie, a nie całością.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Choroba przewlekła wymaga rezyliencji szczególnej — adaptacji do zmiany, która zostaje. Większość osób z czasem znajduje względną równowagę, ale droga bywa trudna. Częstym nieporozumieniem jest słowo „akceptacja”: słyszane jako „pogódź się, zrezygnuj”, budzi opór i poczucie zdrady samego siebie. Tymczasem akceptacja w użytecznym sensie to **„nie walczę z faktem choroby, walczę o to, co dla mnie ważne, mimo niej”** — akceptacja połączona z zaangażowanym działaniem. Pomaga rozdzielenie **kontroli** (na co realnie wpływam) od tego, co poza nią, oraz odbudowa **tożsamości** poza diagnozą (role, wartości, to, czego choroba nie zabiera). Ważne też prawo do **żałoby po zdrowiu** — to normalna reakcja na realną stratę. Osoby z poczuciem sensu radzą sobie z chorobą lepiej, nawet przy podobnym jej nasileniu.

01 Cztery obszary adaptacji

- **żałoba po zdrowiu** — prawo do opłakania utraconej sprawności i planów
- **akceptacja** — uznanie nowej rzeczywistości (nie rezygnacja)
- **przystosowanie** — skupienie na tym, co mogę zrobić
- **tożsamość** — kim jestem poza chorobą

02 Moja żałoba po zdrowiu

Co straciłeś przez chorobę (sprawność, plany, pewność)? Masz prawo to opłakać — to normalna żałoba. Nazwij ją.

CO OPŁAKUJĘ

03 Na co mam wpływ

Rozdziel: na co masz wpływ (leki, dieta, ruch, sen, relacje, nastrój), a na co nie (przebieg, rokowanie)? Skup energię na pierwszej liście.

MAM WPŁYW → ... | NIE MAM → ...

04 Kim jestem poza chorobą

Choroba to część Ciebie, nie całość. Jakie role, wartości i rzeczy są dla Ciebie ważne, a których choroba nie zabiera?

CO NADAL JEST MOJE

Klucz: choroba zabiera część życia — rezyliencja to odkrycie, że reszta nadal jest Twoja. Akceptacja to nie rezygnacja: „akceptuję, że jestem chory; nie akceptuję, że nic nie mogę zrobić”.

Wsparcie grupy osób z tą samą chorobą i pomoc specjalisty mogą bardzo pomóc w adaptacji.